

Pérdida súbita de visión

1. Introducción y relevancia clínica

La **pérdida súbita de visión** (PSV) es una **emergencia oftalmológica y neurológica** que requiere diagnóstico y manejo inmediato para prevenir la ceguera irreversible.

Se define como una **disminución aguda de la agudeza visual, completa o parcial, en uno o ambos ojos**, que ocurre en **minutos a horas (hasta 24–48 h)**.

Relevancia clínica

- Es una **urgencia frecuente en servicios de urgencia y atención primaria**.
 - En la mayoría de los casos, **la visión puede recuperarse si se actúa dentro de las primeras horas**.
 - Puede tener **causas oculares, vasculares o neurológicas**, algunas potencialmente mortales (p. ej., arteritis temporal, oclusión de arteria central).
 - En el **EUNACOM**, es un tema clásico, generalmente presentado como un paciente con “pérdida visual súbita unilateral, sin dolor, con fondo de ojo característico”.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Clasificación fisiopatológica

La pérdida súbita de visión se clasifica según la **localización anatómica del compromiso**:

Nivel afectado	Ejemplo típico	Características
Medios ópticos	Hemorragia vítrea, queratitis, córnea opaca	Visión borrosa, reflejo rojo ausente o turbio.

Retina	Desprendimiento de retina, oclusión arterial o venosa	Fondo de ojo patológico.
Nervio óptico	Neuritis óptica, neuropatía isquémica	Fondo de ojo normal o con edema papilar.
Vías visuales	Lesiones quiasmáticas o corticales	Alteraciones campimétricas específicas, bilateral.

2.2 Mecanismo fisiopatológico

La pérdida visual aguda puede deberse a:

1. **Isquemia retiniana u óptica** (oclusiones vasculares, arteritis temporal).
 2. **Desprendimiento o hemorragia vítrea** (interrupción de la transmisión de luz).
 3. **Inflamación desmielinizante** (neuritis óptica).
 4. **Compromiso neurológico agudo** (infarto occipital, compresión del nervio óptico).
-

2.3 Clasificación clínica por presencia de dolor

Con dolor	Sin dolor
Neuritis óptica	Oclusión arterial o venosa
Glaucoma agudo	Desprendimiento de retina
Queratitis o úlcera corneal	Hemorragia vítrea

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Características clínicas clave

- **Tiempo de instalación:** segundos (vascular), horas (neuritis, desprendimiento), días (hemorragia vítrea).
- **Dolor ocular:** orienta a procesos inflamatorios o glaucomatosos.
- **Compromiso unilateral o bilateral.**
- **Percepción de luces o sombras.**
- **Alteración del reflejo pupilar directo o consensual.**
- **Presencia o ausencia de reflejo rojo.**

3.2 Diagnóstico diferencial principal

Etiología	Presentación clínica	Fondo de ojo	Dolor
Oclusión de arteria central de la retina (OACR)	Pérdida visual súbita, completa, indolora	Retina pálida, mácula rojo cereza	No
Oclusión de vena central de la retina (OVCR)	Visión borrosa, indolora	“Sangre y trueno”: hemorragias difusas	No
Desprendimiento de retina (DR)	Luces, moscas volantes, sombra ascendente	Retina flotante o arrugada	No

Hemorragia vítrea	Visión de “manchas oscuras” o niebla densa	Fondo no visible	No
Neuritis óptica	Dolor con movimientos oculares, pérdida central	Fondo normal o edema leve	Sí
Glaucoma agudo de ángulo cerrado	Dolor intenso, halos, náuseas	Córnea opaca, pupila media fija	Sí
Isquemia del nervio óptico (NOIA)	Pérdida súbita indolora en mayores	Papila pálida y edematosa	No
Infarto occipital (corteza visual)	Hemianopsia homónima bilateral	Fondo normal	No

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria / urgencia

1. **Agudeza visual monocular.**
 2. **Reflejo pupilar directo y consensual.**
 - Pupila relativa aferente (Marcus Gunn) → lesión del nervio óptico.
 3. **Fondo de ojo directo:** buscar retina pálida, hemorragias, edema papilar o reflejo rojo ausente.
 4. **Presión intraocular:** si dolor ocular.
 5. **Movimientos oculares y motilidad.**
 6. **Campo visual por confrontación.**
-

4.2 En atención especializada

Examen	Utilidad
Oftalmoscopia indirecta	Visualiza periferia retiniana.
OCT (tomografía de coherencia óptica)	Evalúa mácula y retina.
Angiografía fluoresceínica	Determina perfusión retiniana.
Ecografía ocular modo B	Diagnostica hemorragia vítrea o desprendimiento.
VSG / PCR	Sospecha de arteritis temporal.
Neuroimagen (TAC / RM cerebral)	Si sospecha compromiso cortical o neurológico.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Principio general

La **mayoría de las causas de pérdida súbita de visión son emergencias**: la derivación debe ser **inmediata a oftalmología**, y el tratamiento debe iniciarse **antes de confirmación definitiva** si se sospecha compromiso vascular o inflamatorio.

5.2 Conducta específica por etiología

1. Oclusión de arteria central de la retina (OACR)

- **Emergencia isquémica ocular** (análoga al ACV).
- Tiempo crítico: **<90 minutos** para evitar necrosis retiniana.

Tratamiento inmediato:

1. **Masaje ocular intermitente:** estimula recanalización.
 2. **Bajar la presión intraocular:**
 - **Acetazolamida EV (500 mg) o manitol 20%.**
 - Hiperventilación con CO₂ (si disponible).
 3. **Derivación urgente a oftalmología** para posible **paracentesis de cámara anterior.**
 4. **Descartar arteritis temporal (en >50 años):**
 - Si sospecha: **prednisona EV 1 mg/kg o metilprednisolona 1 g/día + VSG / PCR.**
-

2. Oclusión de vena central de la retina (OVCR)

- Control de factores de riesgo (HTA, DM, dislipidemia).
 - Derivación oftalmológica para:
 - **Antiinflamatorios intravítreos (anti-VEGF, corticoides).**
 - **Fotocoagulación láser** si isquemia macular.
 - No hay terapia sistémica efectiva comprobada.
-

3. Desprendimiento de retina (DR)

- Derivación inmediata a oftalmólogo.
 - Instruir al paciente a **mantener posición supina** y evitar movimientos oculares bruscos.
 - Tratamiento quirúrgico (retinopexia, vitrectomía o gas intraocular).
 - Éxito >90% si tratado precozmente.
-

4. Hemorragia vítrea

- Evaluar etiología (retinopatía diabética, trauma).
 - Manejo expectante si leve; si densa o persistente, **vitrectomía**.
 - Evitar anticoagulantes innecesarios.
-

5. Neuritis óptica

- **Causa más común de pérdida visual dolorosa en jóvenes.**
- Asociada frecuentemente a **esclerosis múltiple**.

Tratamiento:

- **Metilprednisolona EV 1 g/día por 3 días, luego prednisona oral 1 mg/kg por 11 días.**
 - Pronóstico favorable: recuperación en semanas.
-

6. Glaucoma agudo de ángulo cerrado

- Dolor intenso, visión de halos, pupila fija.

Tratamiento urgente:

- **Acetazolamida 500 mg EV,**
 - **Manitol 20% EV,**
 - **Colirios: timolol, pilocarpina, brimonidina.**
 - Derivación inmediata para **iridotomía láser**.
-

7. Isquemia del nervio óptico (NOIA)

- En mayores de 50 años, evaluar **arteritis temporal**.

Tratamiento:

- **Corticoterapia EV inmediata** sin esperar confirmación.
- **Biopsia de arteria temporal** posterior.

5.3 Medidas generales

- Control estricto de **HTA, DM, dislipidemia**.
- Suspender **tabaco y anticonceptivos orales**.
- Anticoagulación o antiagregación según caso vascular.

6. Complicaciones y pronóstico

Causa	Complicaciones	Pronóstico
OACR	Atrofia óptica, ceguera irreversible	Malo si >90 min sin perfusión
OVCR	Neovascularización, glaucoma	Variable
DR	Pérdida visual permanente si mácula comprometida	Bueno si cirugía precoz
Neuritis óptica	Recaídas, esclerosis múltiple	Bueno (recupera AV en 80%)
Hemorragia vítrea	Desprendimiento traccional	Bueno si vitrectomía oportuna

Glaucoma agudo	Ceguera por daño óptico	Variable, depende de rapidez
NOIA	Atrofia óptica	Limitado

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **La oclusión de la arteria central de la retina es análoga a un ACV ocular: ¡cada minuto cuenta!**
 2. La **presencia o ausencia de dolor** es clave para orientar el diagnóstico.
 3. Un **fondo de ojo pálido con mácula rojo cereza** = OACR (emergencia).
 4. **Desprendimiento de retina** cursa con “luces y sombras en cortina”.
 5. **Neuritis óptica** = mujer joven + dolor con movimientos oculares.
 6. Siempre buscar **factores sistémicos (HTA, DM, arteritis temporal)**.
 7. En atención primaria, **no dilatar la pupila** hasta descartar glaucoma agudo.
-

Errores comunes

- Retrasar la derivación a oftalmología por creer que es “problema ocular menor”.
 - No evaluar reflejos pupilares ni fondo de ojo.
 - Administrar corticoides tópicos sin diagnóstico.
 - No considerar arteritis temporal en mayores con pérdida visual súbita.
 - Omitir control cardiovascular en OVCR.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **pérdida súbita de visión** es una **emergencia médica**: la causa más grave es la **oclusión arterial retiniana**.
2. El **primer paso diagnóstico** es diferenciar **dolorosa vs indolora**.
3. **OACR** → **retina pálida con mácula rojo cereza**; tratamiento urgente en <90 min.
4. **OVCR** → “**fondo en sangre y trueno**”; tratar factores sistémicos + láser / anti-VEGF.
5. **Desprendimiento de retina** → **luces y sombra en cortina**; cirugía precoz.
6. **Neuritis óptica** → **dolor ocular + mujer joven**; tratar con corticoides EV.
7. **Derivar siempre de inmediato** a oftalmología o urgencias, incluso si la visión mejora.